

POST-AMM

REMBOURSEMENT DES PRODUITS DE SANTÉ

Classification des médicaments :

Selon la **santé publique** :

- Produits listés (PMO)
- Produits non listés (dont les PMF)

Selon leur **milieu d'utilisation** :

- Produits en milieu hospitalier
- Produits en ambulatoire

Selon la **protection sociale** :

- Produits pris en charge par un organisme de protection sociale (prix régulé)
- Produits non pris en charge (prix libre)

Procédure d'inscription :

Après l'obtention de l'AMM, le laboratoire doit fournir 2 dossiers s'il veut que son produit soit inscrit sur la liste des spécialités remboursables.

- Dossier **technique** adressé à la **commission de la transparence rattachée à l'HAS**.
- Dossier **économique** adressé au **comité économique des produits de santé CEPS**.

Rappel HAS :

La HAS évalue d'un **point de vue médical et économique** les produits, actes, prestations et technologies de santé, en vue de leur remboursement (évaluation de l'utilité des biens et services).

Contribue à la **régulation du système de santé par la qualité et l'efficience** (résultat obtenu/moyens investis).

Élabore des recommandations sur les stratégies de prise en charge.

Commission de Transparence :

Rattachée à l'H.A.S. depuis janvier 2005 (une des 8 commissions spécialisées).

Instance scientifique qui évalue les médicaments ayant obtenu leur AMM, lorsque le laboratoire qui les commercialise souhaite obtenir leur inscription sur la liste des médicaments remboursables (art L.162-17 du Code de la SS et L.5123-2 du CSP).

Examine les demandes d'inscription, d'extension d'indications thérapeutiques ou de réinscription

- sur la liste des **spécialités remboursables**,
- sur la liste des **médicaments agréés aux collectivités**.

Réévalue les classes thérapeutiques.

Donne un avis sur des documents relatifs au bon usage du médicament (fiches de transparence, recommandations, référentiels de bon usage).

Rédige la **Fiche d'Information Thérapeutique** (FIT) des médicaments d'exception.

Médicaments : SMA/SMR :

Article R163-3 du code de SS

- Les médicaments sont inscrits sur la liste (des médicaments remboursables) prévue au 1er alinéa de l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du **service médical attendu/rendu (SMA/SMR)** qu'ils apportent indication par indication.
- La validité de l'inscription des médicaments est de **5 ans au plus mais peut être renouvelée/modifiée**.
- L'appréciation prend en compte **5 critères liés à la valeur intrinsèque** du produit :
 - **efficacité** et effets indésirables du médicament,
 - place dans la **stratégie thérapeutique**, notamment au regard des autres thérapies disponibles,
 - **gravité de l'affection** à laquelle il est destiné,
 - caractère **préventif**, **curatif** ou **symptomatique** du traitement médicamenteux
 - **intérêt** pour la santé publique.

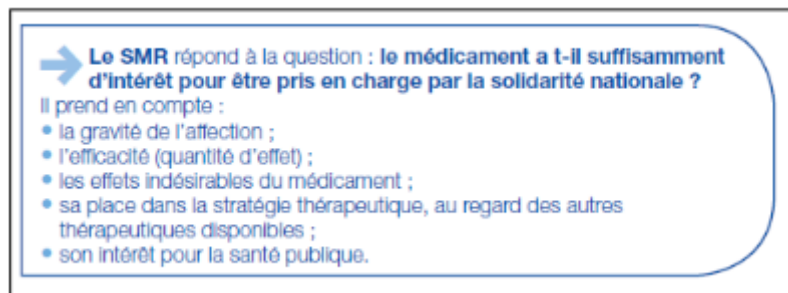
Se fait par rapport à l'évaluation de la population cible.

Selon les indications, un avis peut comporter plusieurs SMR différents.

Le niveau de SMR/SMA **conditionne le taux de prise en charge**.

Les médicaments dont le **SMR est insuffisant** au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles, ne sont **pas inscrits sur la liste** (pas de prise en charge).

Les **génériques** appartenant aux **mêmes groupes génériques que les spécialités de référence**, ne sont **pas examinés** par la Commission (⇒ même taux de prise en charge).



Cas des médicaments d'exception :

L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments **particulièrement coûteux et d'indications précises**, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont **remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical**.

Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste, une **fiche d'information thérapeutique (FIT) établie par la commission de Transparence**.

Destinée aux professionnels de santé, la FIT rassemble les indications thérapeutiques et les modalités d'utilisation du médicament, en particulier les **règles de prescription** et de délivrance.

Elle mentionne, le cas échéant, les restrictions apportées par l'AMM à la prescription et à la délivrance du médicament dit d'exception (médicaments soumis à prescription restreinte).

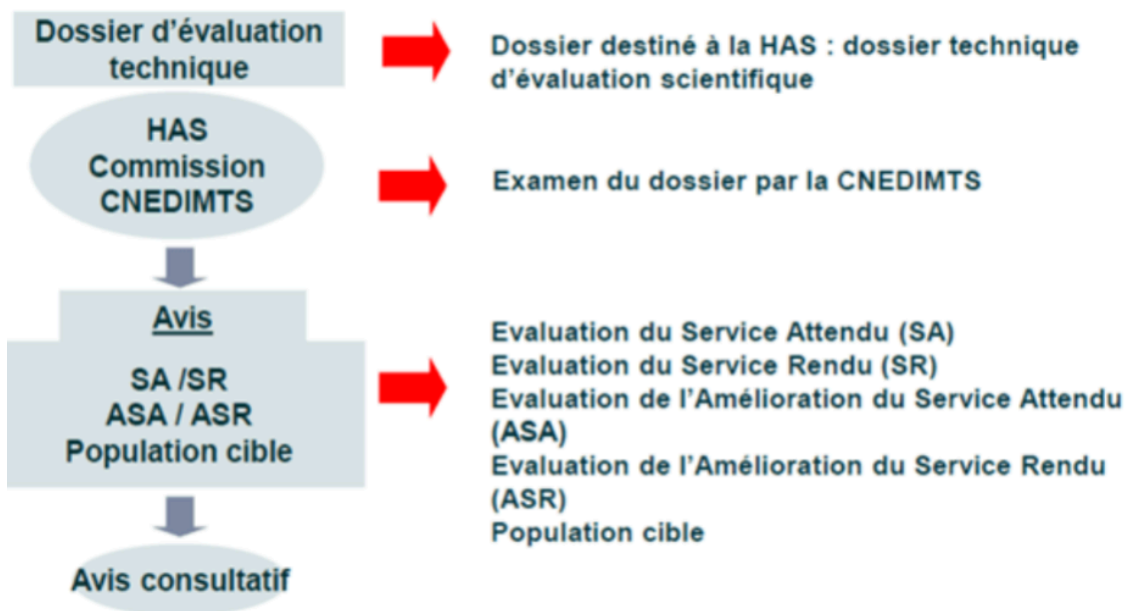
Agrément aux collectivités :

Pour être achetés et utilisés à l'hôpital, les médicaments doivent être **inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées** à l'usage des collectivités et divers services publics, établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, **après avis de la HAS**.

Cet agrément aux collectivités est demandé, soit isolément, soit simultanément à la demande d'inscription sur la liste des spécialités remboursables

Modalité de remboursement des DM :

Procédure d'inscription :



La CNEDiMTS :

Rattachée à la HAS

Examine toute **question relative à l'évaluation et au bon usage** des DM et des technologies de santé.

Formule des **recommandations sur des bases scientifiques et rend des avis** en vue du remboursement des DM à **usage individuel** ou d'autres produits à visée diagnostique, thérapeutique ou de compensation du handicap (à l'exclusion des médicaments)

Dispositifs médicaux : SA/SR

SA/SR et SMA/SMR : mêmes critères.

Concerne une population cible (susceptible de bénéficier du dispositif dans l'indication revendiquée).

Inscription sur la liste des produits ou prestations (LPP)

- sous **nom générique** : démontrer l'équivalence du DM concerné avec un DM déjà inscrit. L'inscription est alors automatique.
- ou **nom de marque** : faire un dossier complet.

Quelle argumentation pour le Service Attendu ?

1. Description et évaluation du **besoin médical**

- **Gravité** de la pathologie/handicap
- Données épidémiologiques : prévalence/incidence
- Population de patients concernés

2. **Stratégie** thérapeutique actuelle

- Moyens thérapeutiques existants
- Stratégie de référence
- Place du DM évalué

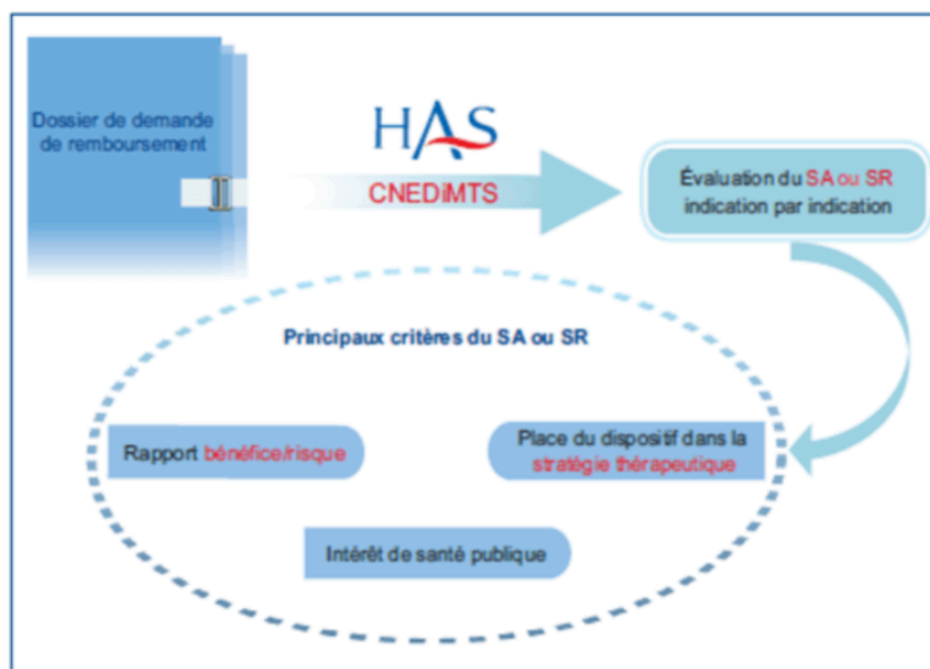
3. **Effet clinique** du DM évalué

- Effet thérapeutique /diagnostic /compensation du handicap / Risques
- Fondé sur des études cliniques publiées ou à défaut des rapports d'études

4. **Intérêt** de santé publique

- Impact prévisible sur le système de soins/ politique et programmes de santé publique
- Impact potentiel sur la santé de la population

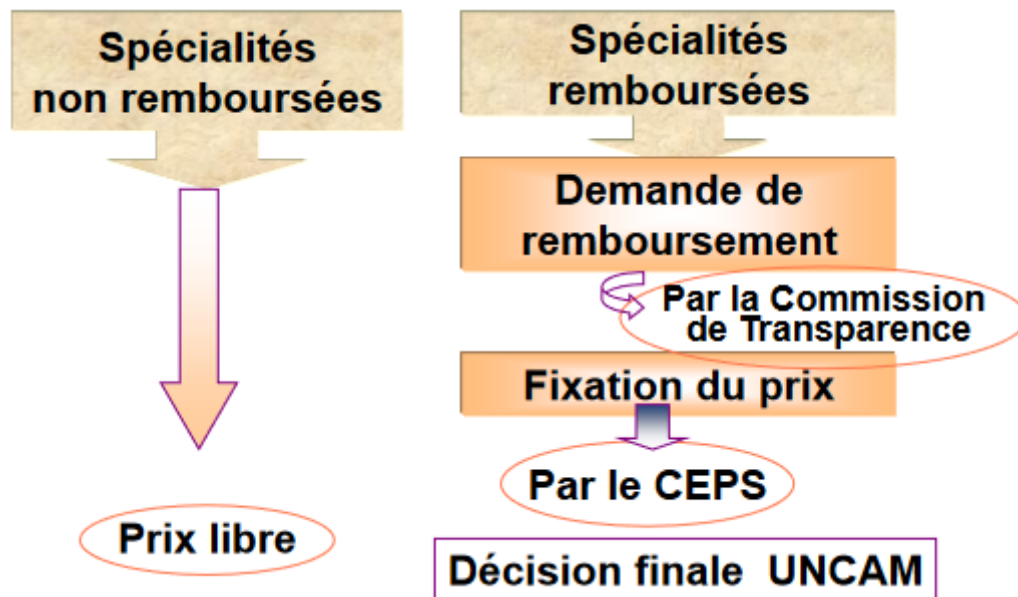
Appréciation du SA/SR par la CNEDiMTS :



PRIX DES PRODUITS DE SANTÉ :

Fixation du prix : Médicaments → Les critères :

Différentes catégories de spécialité selon le type de commercialisation :



Procédure d'inscription :

Une fois l'AMM obtenue → **Indications définitives**

Le labo fournit 2 dossiers de demandes :

- Dossier Technique
- Dossier économique

Le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) :

Organisme interministériel, sous l'autorité conjointe des ministres chargés de la **santé**, de la **sécurité sociale** et de l'**économie**.

Principalement chargé par la loi, de **fixer les prix des médicaments et les tarifs des DM à usage individuel, pris en charge par l'assurance maladie** (pour les autres, le prix est fixé librement par l'industriel).

2 sections : la section du médicament et la section des DM.

Prix de vente au public :

La fixation du prix tient compte, :

- de **l'amélioration du service médical rendu** (attendu) (ASMR/ASMA) apportée par le produit
- des **prix des produits à même visée** thérapeutique
- des **volumes de vente** prévus ou constatés
- des **conditions prévisibles et réelles** d'utilisation du produit (rôle de la HAS).

ASMR / ASMA :

L'appréciation de l'ASMR fait appel à une **évaluation comparative** par rapport aux médicaments, déjà commercialisés dans la même indication.

Mesure du **progrès apporté par le produit** de santé par rapport au traitement de référence. Somme des avantages que procure le traitement en termes **d'efficacité**, de **tolérance**, **d'utilité** et **d'intérêt thérapeutique** pour le malade.

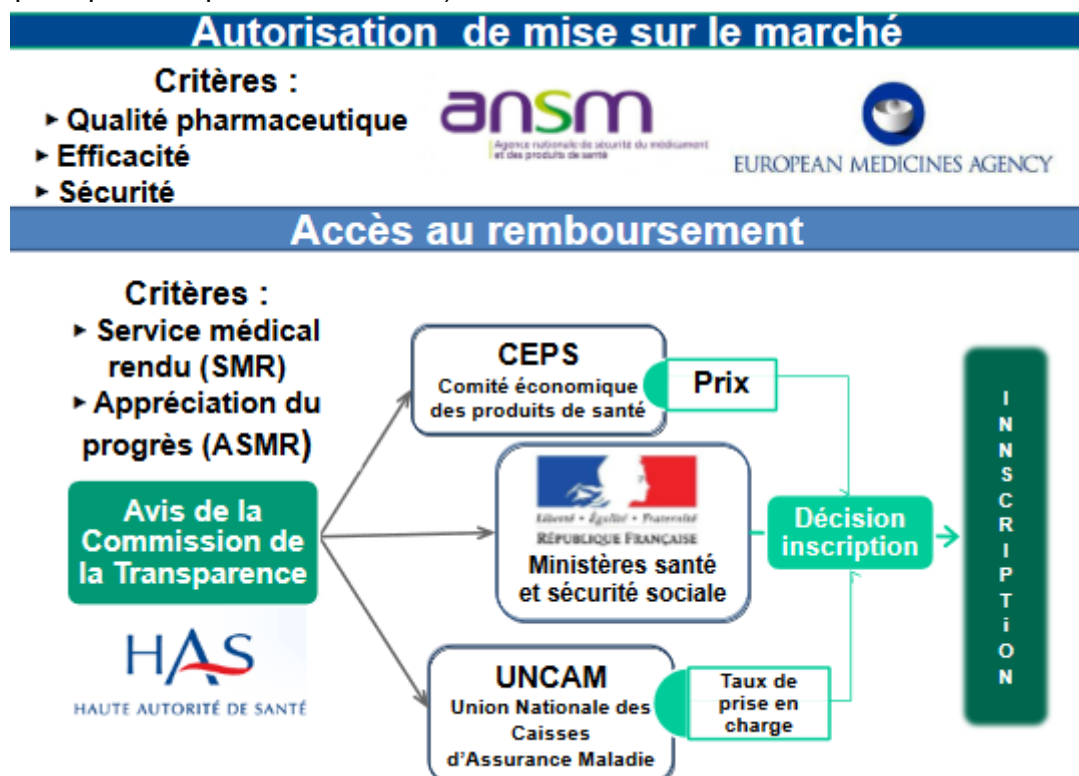
Il s'agit en quelque sorte de la « valeur ajoutée relative ».

Niveaux d'ASMR : cotation de I à V

Selon l'appréciation du progrès / aux traitements ou la prise en charge déjà existants, l'amélioration est définie comme :

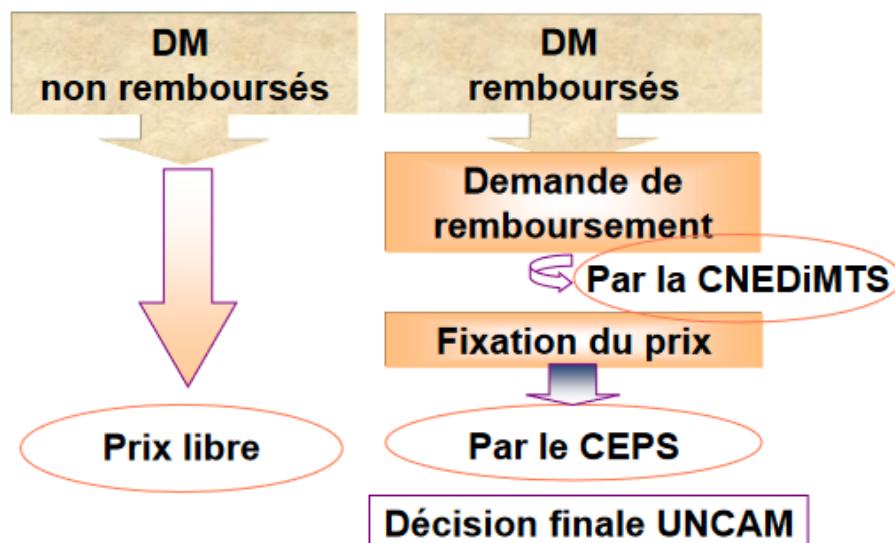
- Niveau I ⇒ Majeure
- Niveau II ⇒ Importante
- Niveau III ⇒ Modérée
- Niveau IV ⇒ Mineure
- Niveau V ⇒ Pas d'amélioration ⇔ absence de progrès thérapeutique : cas des génériques.

Remarque : un médicament peut avoir un bon SMR mais un ASMR faible. (utilité thérapeutique mais pas d'amélioration)

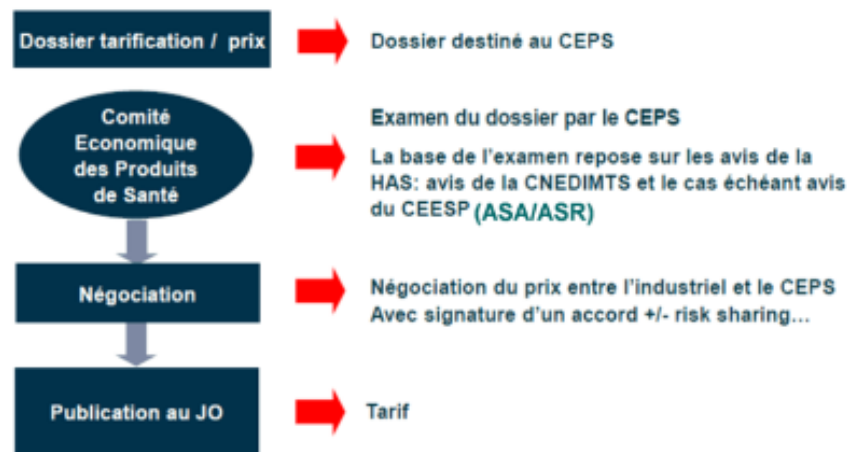


Fixation du prix : DM → Les critères :

Différentes catégories :



Procédure d'inscription :



Prix de vente au public :

La fixation du prix tient **compte de l'amélioration du service rendu** (attendu) (ASR/ASA) apportée par le produit.

Évaluation comparative par rapport :

- produit, acte ou prestation comparable
- précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement.

DM : ASA/ASR (Amélioration Service Attendu/Rendu) :

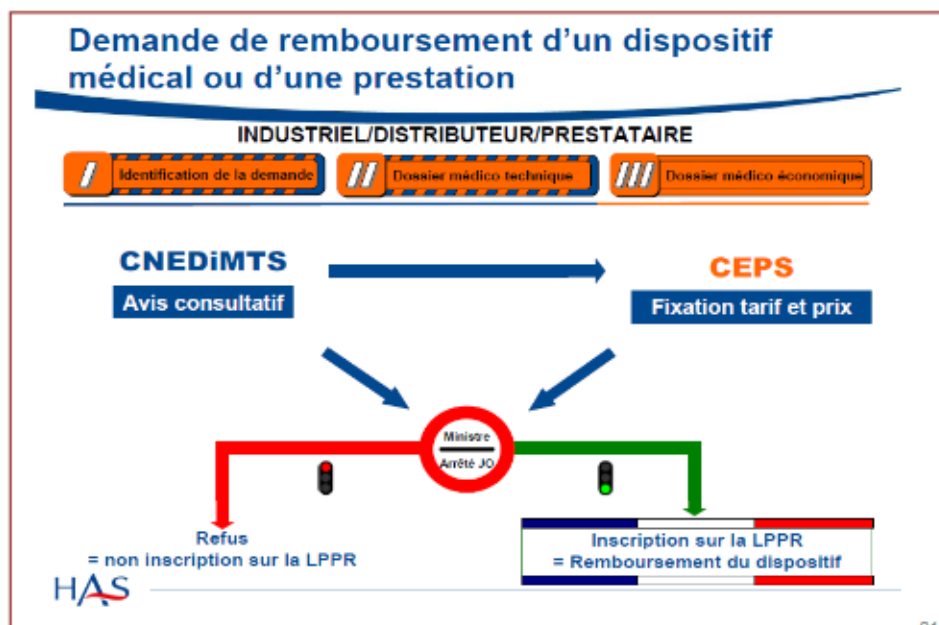
Nature de l'ASA :

- clinique (mortalité, morbidité, compensation d'un handicap)
- qualité de vie
- tolérance
- commodité d'emploi pour le patient

5 niveaux d'ASR/ASA

Amélioration

- Niveau I ⇒ Majeure
- Niveau II ⇒ Importante
- Niveau III ⇒ Modérée
- Niveau IV ⇒ Mineure
- Niveau V ⇒ Pas d'amélioration / pas de progrès thérapeutique : cas de la ligne générique.



Participation de l'assuré :

Article R322-1 du code de la SS

La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2, est **fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie** (UNCAM) dans les limites suivantes :

- Est **supprimée** pour certains produits reconnus comme **irremplaçables** et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
- Est **supprimée** lorsque le **bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé** et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la HAS (ALD30), pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint.

Les taux de remboursement :

Art. L162-16 Code SS

Les différents taux de remboursement s'appliquent soit sur la **base du prix de vente** (prix limite de vente fixé réglementairement) ; soit sur **la base d'un tarif forfaitaire de responsabilité** (T.F.R.) : base pour le remboursement de certains médicaments (ex : génériques).

DISTRIBUTION EN GROS :

Etablissements pharmaceutiques :

Fond de commerce et d'industrie soumis à des règles particulières qui trouvent leur origine dans **l'intérêt de la santé publique**.

Selon les activités pratiquées **différentes catégories** d'établissements.

Ceci concerne les médicaments, mais aussi les produits et objets entrant dans le monopole pharmaceutique.

Ont l'interdiction légale de vendre directement au public les médicaments qu'ils fabriquent ou stockent (sauf dérogations visant les praticiens pour leur usage professionnel, les centres de vaccination, les centres de planification ou de vaccination familiale).

Il existe environ **950 établissements** pharmaceutiques en France.

13 Catégorie d'établissements pharmaceutiques :

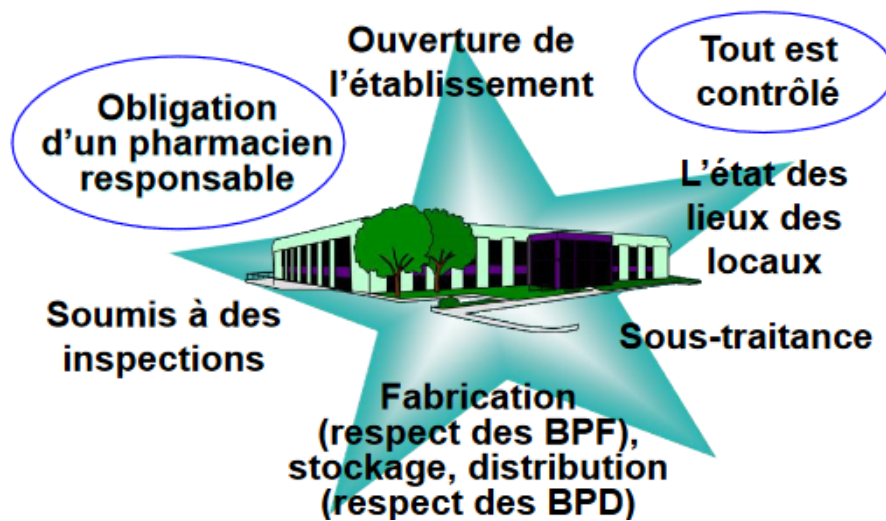
Décret du 11/02/1998

1. Le fabricant
2. L'importateur
3. L'exploitant
4. Le dépositaire
5. Le grossiste-répartiteur « médicaments »
6. Le grossiste-répartiteur « autres produits et objets » (« distributeur »)

Les établissements de distribution de médicaments ou produits :

7. destinés à l'exportation
8. à vocation humanitaire
9. de médicaments dérivés du sang
10. de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme
11. de plantes médicinales
12. de gaz à usage médical
13. de service de santé des armées

Fonctionnement d'un établissement pharmaceutique :



Le Pharmacien Responsable :

En France, le Pharmacien Responsable est doté d'une **position statutaire** (Art R-5124-36 du CSP), qui couvre des **responsabilités plus larges que celles des « personnes qualifiées »** sous le système actuel de l'U.E., telles que la **qualité pharmaceutique, la Pharmacovigilance, la distribution, la promotion.**

Il **organise et supervise toutes les opérations pharmaceutiques** de la société selon les activités du site pharmaceutique.

Définition CSP :

Fabricant : entreprise ou organisme se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme, à la **fabrication de médicaments**, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et au 4° de l'article L. 5121-1 (POD).

La fabrication comprend les opérations concernant (BPF) :

- **l'achat** des matières premières et articles de conditionnement,
- les **opérations de production**, de contrôle de la qualité, de libération des lots
- les **opérations de stockage** correspondantes, telles qu'elles sont définies par les BP prévues à l'article L. 5121-5 applicables à cette activité

Exploitant : entreprise ou organisme se livrant à l'exploitation de médicaments (statut pharmaceutique s'appliquant aux **opérations commerciales** pour les médicaments en France) autres que des médicaments expérimentaux, générateurs, trousseaux et précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1.

L'exploitation comprend les opérations de :

- vente en gros ou de cession à titre gratuit,
- stockage,
- contrôle de la publicité, de l'information médicale,
- pharmacovigilance,
- suivi et de rappel des lots,
- réclamations etc.

L'exploitation est **assurée** soit :

- par le **titulaire de l'AMM** mentionnée à l'article L. 5121-8, de l'ATU mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 ou de l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 (Med. homéop. et plantes traditionnelles),

- pour le compte de ce titulaire, par une **autre entreprise ou un autre organisme**,
- par **l'un et l'autre**, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitutives de l'exploitation du médicament ou produit.

Et pour les DM ? :

Le Fabricant :

- **Fabricant du produit**, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne .
- **Toute autre personne qui se présente comme** fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
- Celui qui **procède à la remise en état** du produit.

Le circuit de distribution des produits de santé :

Quel que soit le circuit choisi, le médicament, dès sa sortie des chaînes de production, doit être **acheminé dans de bonnes conditions** auprès des points de vente et/ou de dispensation, répartis sur l'ensemble du territoire.

Cette distribution exige **3 critères** :

- **qualité**,
- **régularité**,
- **rapidité**,

Selon l'activité, on distingue : les **grossistes répartiteurs** et **distributeurs** et les **dépositaires**.

Les Grossistes répartiteurs :

Article R5124-2 du CSP

Grossiste-répartiteur : entreprise se livrant à **l'achat et au stockage** de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme en vue de leur distribution en gros, et en l'état.

Les Distributeurs :

Article L 421-1 du Code de la consommation

Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont **l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit**.

Article R5124-2 du CSP

Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments : l'entreprise se livrant à **l'achat et au stockage** de produits et articles (conformes à la pharmacopée), générateurs, trousseaux ou précurseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4211-1 ou de POD mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1 en vue de leur distribution en gros et en l'état.

Distributeur en gros de produits pharmaceutiques [autres que les médicaments] :

- à l'exportation;
- à vocation humanitaire;
- de médicaments expérimentaux;
- de plantes médicinales;
- de gaz à usage médical;
- du service de santé des armées;

Etablissement pharmaceutique pour la protection de la population :

Établissement pharmaceutique ouvert par **l'Agence nationale de santé publique**, se livrant à des **opérations d'achat, de fabrication, d'importation, d'exportation** de produits

nécessaires à la protection de la population **face aux menaces sanitaires graves**, en vue de leur distribution.

Se livre, le cas échéant, à des **opérations d'exploitation comprenant l'information, la pharmacovigilance, le suivi des lots** et, s'il y a lieu, leur **retrait** ainsi que les **opérations de stockage** correspondantes.

Centrales d'achat pharmaceutique :

Créées par le décret du 19 juin 2009.

Structures de **Regroupement à l'Achat devenues Établissement Pharmaceutique**,

Ont pour vocation **d'acheter et stocker** des médicaments, à **l'exception des médicaments remboursables par l'AM**, en vue de leur distribution en gros et en l'état, à des pharmaciens titulaires d'officine adhérents.

On en recense une **vingtaine** en France, dont la majorité se trouve en Ile de France et dans la région Centre (9 régions).

Les obligations légales :

Décret du 11 février 1998 (s'appliquent à tout établissement de répartition pharmaceutique) :

- chaque établissement est **sous la responsabilité d'un pharmacien responsable** qui, selon l'effectif, est assisté d'un ou plusieurs pharmaciens délégués ;
- **doit desservir toutes les pharmacies qui leur en font la demande** sur « le secteur d'activité déclaré »
- doit **référer au moins 9/10 des présentations des médicaments** exploitées en France, auxquelles s'ajoutent les accessoires médicaux ;
- avoir un **stock permettant de satisfaire au moins deux semaines de consommation** ;
- **livrer tout médicament du stock dans les 24h** suivant la réception de la commande.

Depuis le 24 août 2008, les grossistes-répartiteurs ont **l'obligation de participer à un système d'astreinte les week-ends et jours fériés** pour permettre la livraison des médicaments dans les situations d'urgence.

Attribution du PR dans ces entreprises :

Organise et surveille l'ensemble des opérations de stockage, livraison, publicité et information.

Concourt au **suivi et au retrait des lots** (vigilances), à la distribution, l'exportation des médicaments et autres produits.

Veille aux **bonnes conditions de transport** (conservation, sécurité...) et aux respect des BP de distribution en gros (processus systématique d'évaluation, de contrôle, de communication et de revue des risques qualité du médicament tout au long du cycle de vie du produit).

Les Dépositaires :

Article R5124-2

Dépositaire : **entreprise** se livrant, d'ordre et pour le compte d'un ou plusieurs exploitants de médicaments, de générateurs, trousseaux ou précurseurs ou d'un ou plusieurs fabricants ou importateurs d'objets de pansement ou articles présentés comme conformes à la Pharmacopée ou de POD, **au stockage de ces médicaments et produits**, objets ou articles **dont elle n'est pas propriétaire**, en vue de leur distribution en gros et en l'état.

Le dépositaire n'a **pas d'obligations légales**, et il n'est **pas propriétaire de son stock**.
Il signe simplement un **contrat avec les laboratoires fabricants**, qui définit un cahier des charges et fixe leur rémunération.
Ils proposent leurs services dans le cadre de la **vente directe aux officines mais aussi auprès des grossistes-répartiteurs** (85% des approvisionnements à l'officine transitent par les dépositaires).

DISTRIBUTION AU DÉTAIL → LA PRESCRIPTION

Classification des médicaments (SP) :

Lorsqu'elles autorisent la mise sur le marché d'un médicament, les autorités compétentes précisent la classification du médicament en :

- **médicament non soumis à prescription** (attention : médicament à prescription facultative en France pour la prise en charge par la SS)
- médicament **soumis à prescription médicale**.

Sont **soumises à prescription médicale obligatoire**, les **spécialités susceptibles de présenter directement ou indirectement un risque** pour la santé, ou nécessitant une surveillance particulière, ou contenant des substances classées comme substances vénéneuses.

Les spécialités sont classées en fonction de leur degré de dangerosité.

Référentiel national :

Articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7, R. 5132-1, R. 5132-2 du CSP : précisent les règles de classification des médicaments et autres produits de santé.

Des arrêtés publient les listes de substances et produits concernés.

A chaque liste correspond une **réglementation stricte**, concernant la **présentation**, la **prescription** et les **conditions de circulation et de détention** de ces produits.

Convention internationales :

Cadre juridique applicable aux **drogues** ⇔ 3 conventions internationales qui **lient les États signataires et les obligent à une transposition dans leur législation interne** :

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (modifiée par un protocole en 1972) :

- **est un stupéfiant** : une substance figurant sur la **liste des stupéfiants** annexée à la convention de 1961 ;
- principales substances placées sous contrôle : opium, morphine, héroïne, méthadone, codéine, cocaïne, cannabis...

Convention de 1971 sur les substances psychotropes

- développement de l'industrie chimique et pharmaceutique ⇒ trafic de nouvelles drogues synthétiques, non visées par la Convention unique de 1961 nouvelle convention.

Renforcement des dispositions par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988).

Le classement français :

Découle du **classement international mais est plus strict**.

Organisé par l'article L.5132-1 du CSP qui précise la catégorie générique des « **substances vénéneuses** », lesquelles regroupent :

- les substances stupéfiantes,
- les substances psychotropes,

- les substances inscrites sur les listes I et II,
- certaines « substances dangereuses ».

Médicaments classés sur les listes I et II :

Définis à l'article L.5132-6 du CSP.

Médicaments qui présentent pour la santé, des **risques directs ou indirects** et qui ne peuvent être **délivrés que sur ordonnance**, soit **renouvelable (liste II)**, soit **non renouvelable (liste I)** (une nouvelle prescription est nécessaire pour la poursuite du traitement).

Médicaments soumis à la prescription médicale spéciale :

Il s'agit :

- des stupéfiants
- des assimilés stupéfiants

Liste des stupéfiants **placés sous contrôle international** en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961(lutte contre la toxicomanie et le trafic international).

Substances classées stupéfiants :

Toutes les substances **classées stupéfiants dans la convention de 1961** : coca, pavot à opium, cannabis ainsi que leur dérivés : morphine, héroïne, méthadone, cocaïne, cannabis et sa résine...

Certaines substances **classées psychotropes dans la convention de 1971** mais sur lesquelles on a souhaité **instituer un contrôle fort** : hallucinogènes, amphétamines, MDMA (ecstasy) etc.

Certaines substances **non classées au niveau international**, mais qu'il est apparu **nécessaire de contrôler au plan national** : champignons hallucinogènes, nouvelles drogues de synthèse...

Assimilés stupéfiants :

Relèvent de la **liste I** des substances vénéneuses, mais sont **partiellement soumis à la réglementation des stupéfiants** (rohypnol, subutex, buprenorphine (temgésic), tranxène, rivotril...).

Cas particuliers, pour lesquels certaines mesures restrictives relevant de la réglementation des stupéfiants s'appliquent, mais pas toutes.

Substances classées psychotropes :

Essentiellement des substances entrant dans la **composition de tranquillisants ou d'hypnotiques** (benzodiazépine, barbituriques, etc.).

Y figurent également des **substances non classées par la convention de 1971** (ex zopiclone [imovane®]).

Médicaments soumis à prescription restreinte :

L'AMM d'un médicament peut classer celui-ci dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte suivantes :

- Médicaments réservés à **l'usage hospitalier**
- Médicaments de **prescription hospitalière**
- Médicaments de **prescription initiale hospitalière**
- Médicaments **réservés à certains spécialistes**

- Médicaments nécessitant une **surveillance particulière**

La prescription des produits de santé :

Support écrit obligatoire ou facultatif.

- **Obligatoire**

- quand le produit est listé
- et/ou en vue d'un remboursement

- **Facultatif**

- quand le produit n'est pas « listé »
- quand le produit n'est pas pris en charge par un organisme de protection sociale

Un support à deux missions

- garantir la protection de la santé
- obtenir la prise en charge par le organismes de SS

L'ordonnance est le document qui indique la prescription.

Permet au malade de connaître son traitement et au pharmacien de lui délivrer.

Prescripteurs :

Les pharmaciens délivrent des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments classés comme stupéfiants, sur prescription ou sur commande à usage professionnel des :

- médecin ;
- chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
- sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ;
- vétérinaire pour la médecine vétérinaire.

Cas des infirmiers/renouvellement des contraceptifs oraux sous certaines conditions (art. L. 4311-1 du CSP) et prescription substituts nicotiniques.

Art. R.5123-2 du CSP

En règle générale, la **prescription est renouvelable par période maximale d'un mois** ou de trois mois (conditionnement > à un mois) dans la **limite de 12 mois de traitement**.

La durée maximale de la prescription peut être limitée dans certains cas (hypnotiques, anxiolytiques).

Il existe **5 types d'ordonnance** :

- ordonnance **simple**
- ordonnance **sécurisée** (stupéfiants)
- ordonnance **bi-zone** (ALD)
- ordonnance des **médicaments d'exception** (à 4 volets)
- ordonnance **électronique** (en expérimentation dans 3 départements. Généralisation 2019 ?)

Seuls des **éditeurs agréés par l'AFNOR sont autorisés à fabriquer les ordonnances sécurisées**.

Dispositions générales :

Art. R.5123-1 du CSP, art. R.161-45 du Code de la Sécurité sociale

S'appliquent à **tous les médicaments**, qu'ils soient de prescription obligatoire ou non, dès lors qu'ils sont présentés au remboursement par l'assurance maladie.

Pour **permettre la première délivrance** :

- Ordonnance datant de moins de 3 mois (sauf stupéfiants et produits hors listes).

Pour **permettre la prise en charge** l'ordonnance doit comporter :

- identification du prescripteur (avec numéro Adeli),

- date de la prescription
- identification du malade (nom et prénom)
- médicaments : nom de marque ou DC du principe actif, forme, posologie, durée du traitement et mode d'emploi ou nombre d'unités du conditionnement
- mentions telles que : à renouveler ou à ne pas renouveler, non substituable, non remboursable, nombre de renouvellements etc.
- signature du prescripteur.

Dispositions applicables à certaines catégories de médicaments :

Médicaments relevant des **listes I et II**

- Le cas échéant : le nombre de renouvellements
- Si nécessaire : la taille/le poids du patient (pour les enfants de 0 à 14 ans, l'âge et le poids doivent être mentionnés).

Médicaments soumis à **prescription restreinte** (PH, PIH, RS, SP)

- En fonction des spécialités concernées, il pourra être nécessaire de faire figurer un certain nombre de **mentions particulières** telles que **spécialité** du prescripteur, **date** à laquelle certains examens ont été ou doivent être effectués, **service hospitalier responsable** de la prescription initiale.

Médicaments classés comme **stupéfiants**

- La prescription doit être effectuée sur une **ordonnance sécurisée** (art. R.5132-5 du CSP).
- Les mentions prévues pour les médicaments des listes I et II **s'appliquent à la prescription de médicaments stupéfiants**.
- **Doivent figurer**, en outre, et en toutes lettres (art. R.5132-29 du CSP) :
 - le nombre d'unités thérapeutiques par prise,
 - le nombre de prises,
 - le dosage des spécialités.
- La durée de prescription **ne peut excéder 28 j**.
- Peut être **réduite à 7 ou 14 j** pour certains médicaments (art. R.5132-30 du CSP). Pour ces médicaments, la **délivrance doit être fractionnée** (décidée par arrêté ministériel, qui mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction).
- Le prescripteur mentionne sur l'ordonnance la **durée de traitement correspondant à chaque fraction**. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la **mention "délivrance en une seule fois"**.
- **Règle des 3 jours :**
- L'ordonnance ne peut être **exécutée dans sa totalité** que **si elle est présentée dans les 3 jours**, sinon on délivre la quantité pour la durée qui reste à courir.
- Règle du **non chevauchement**
- Le **renouvellement** d'un médicament stupéfiant ne peut avoir lieu **qu'après un délai déterminé**, résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
- Une **nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée pendant la période déjà couverte** par une précédente ordonnance, sauf si le prescripteur en décide autrement par mention expresse portée sur l'ordonnance.

Cas des médicaments d'exception :

Ils font l'objet d'une prescription sur une **ordonnance spécifique dite « 4 volets »**.

La prescription doit **préciser l'indication pour laquelle le médicament est prescrit** afin que soit vérifié qu'elle entre dans « l'indication précise » définie par l'AMM et par la Commission Transparence qui en a défini le remboursement.

La FIT est une **aide au prescripteur** afin qu'il puisse effectuer ces prescriptions de manière adaptée.

Les médicaments non listés :

Sont en **vente libre**, disponibles sans ordonnance, remboursables ou non.

Souvent utilisés en **automédication**.

Il existe 2 catégories :

- médicaments **conseils** (pharmaceutique)
- médicaments **grand public** (promotion assurée dans les médias, vente sur une surface libre).

Prescription des DM :

Médecins

.... prescription limitée par le CSP et par la déontologie /règles de compétence

Sages-femmes

Chirurgiens-dentistes

Masseurs -kinésithérapeutes

Infirmiers

Pédicures podologues

.... prescription de produits en rapport avec leurs activités.

DISTRIBUTION AU DÉTAIL : LA DÉLIVRANCE ET DISPENSATION

Les médicaments :

Définitions :

Art. L 5125-1 du CSP modifié par la loi du 29 décembre 2011 JO du 30 décembre 2011

On entend par **officine**, l'établissement **affecté à la dispensation au détail** des médicaments, produits et objets mentionnés à l'art. L. 4211-1, ainsi qu'à **l'exécution des préparations** magistrales ou officinales etc.

Monopole pharmaceutique :

En France, pour des raisons de santé publique, la **pharmacie d'officine détient le monopole de la vente de médicaments** (compétence reconnue).

Article L4211-1 CSP

Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code:

La vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments, des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ainsi que des générateurs, trousseaux ou précurseurs ;

Les pharmaciens **ne peuvent conseiller**, dispenser et vendre dans leur officine que les produits qui **correspondent à leur champ d'activité professionnel**:

- Médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine
- Objets et pansements, articles, conformes à la pharmacopée,
- Insecticides et acaricides

- Plantes médicinales de la Pharmacopée
- Dispositifs de diagnostic in vitro

Arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine, modifiée par l'Arrêté du 18 janvier 2016.

Arrêté de 2016 :

- 1° Les médicaments à usage humain
- 3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact
- 5° Les DM à usage individuel, y compris les assistants d'écoute pré-réglés d'une puissance maximale de 20 décibels, à l'exception des dispositifs médicaux implantables
- 15° Les DM de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public (tests de grossesse, autotests)
- 18° **Les appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation...**
- 20° Les équipements de protection individuelle de protection solaire
- 21° Les équipements de protection individuelle d'acoustique adaptés au conduit auditif
- 23° Les équipements de **protection individuelle respiratoire**
- 24° Les **éthylotests**

Dispositions transversales "fondamentales" :

Code de la consommation

- Obligation **précontractuelle** d'information
- Obligations **contractuelles** :
 - Obligation générale **d'information** (vendeur et revendeur)
 - Obligation générale de **prévention** (produits et services /sécurité légitime)

Ar. du 28 novembre 2016 relatif aux BP de dispensation des médicaments :

Entrées en vigueur le 01/02/17.

Précisent les **différentes étapes de la dispensation** des médicaments à prescription obligatoire ou facultative.

Envisagent la voie à suivre dans le cas de médicaments prescrits hors de l'UE.

Précisent la **définition du conseil pharmaceutique**.

Introduisent l'obligation de mettre en place une **procédure de traitements des alertes sanitaires**.

Acte pharmaceutique / déontologie :

Acte de dispensation = acte intellectuel

Le pharmacien doit **assurer**, dans son intégralité, l'acte de **dispensation** du médicament, associant à sa délivrance :

1. **L'analyse** pharmaceutique de **l'ordonnance** médicale si elle existe ;
2. La **préparation éventuelle des doses** à administrer (préparations magistrales de gélules, de sachets, de paquets etc...)
3. La **mise à disposition des informations** et les conseils nécessaires au bon usage du médicament (BUM).

Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.

Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, **participer au soutien apporté au patient**.

L'analyse pharmaceutique de la prescription :

Trois validations de la prescription avant toute dispensation :

- Validation de **l'habilitation du prescripteur** à prescrire (professionnel médical, médecin généraliste ou spécialiste, ou auxiliaire médical)
- Validation scientifique pour la **sécurité** du patient
- Validation de la présence des **mentions obligatoires**.

Sur le **plan réglementaire**, vise à vérifier que **rien n'interdit la délivrance** des médicaments prescrits (prescripteur, identifiants du patient, du service, etc.).

Sur le **plan pharmaco-thérapeutique**, consiste notamment à vérifier les **contre-indications en fonction de la physiopathologie** du patient, à gérer les interactions médicamenteuses, et à s'assurer des bonnes posologies et des modes d'administration.

Lors de l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, le rôle du pharmacien est de **procéder aux vérifications réglementaires de la prescription**.

Il peut et doit **refuser la délivrance en cas de non-conformité** aux obligations réglementaires liées au(x) médicament(s) prescrit(s), et prendre contact avec le prescripteur afin qu'il y apporte les modifications nécessaires.

Les Problèmes :

Non conformité aux référentiels/contre-indication

Indication non traitée

Sous-dosage/Surdosage

Médicament non indiqué

Interaction à prendre en compte, précaution d'emploi, association déconseillée, association CI

Effet indésirable

Voie/administration inappropriée

Traitement non reçu

Les Solutions :

Ajout (prescription nouvelle)

Arrêt

Substitution/Echange

Choix de la voie d'administration

Suivi thérapeutique

Optimisation des modalités d'administration

Adaptation posologique

Les **personnes habilitées** à exécuter les ordonnances les **enregistrent** sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité.

Les **enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans** et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite

Pour les **stupéfiants**, **toute entrée et toute sortie doit être inscrite** par le pharmacien sur le registre comptable des stupéfiants.

L'inscription des entrées et des sorties se fait à chaque opération en **précisant la date** à laquelle elle est établie.

Une **balance mensuelle des entrées et des sorties** est portée sur le registre des stupéfiants, et un inventaire annuel du stock est obligatoire.

Dispensation du Médicament :

Pour le pharmacien, la **prise en charge de l'ordonnance est possible pendant toute la validité de celle-ci** c'est à dire un an à partir de la date de prescription. Il n'y a que la **dispensation qui s'effectue pour des périodes de 1 à 3 mois**.

Il est **interdit de délivrer un médicament non autorisé** (cad sans AMM pour l'indication concernée), en dehors de la procédure de la prescription hors AMM (rôle majeur du prescripteur / information du patient).

Monopole et libre accès :

Le pharmacien veille à ce que le **public ne puisse accéder directement** aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le **respect du secret professionnel**.

Toutefois, depuis le décret du 30 juin 2008, le pharmacien **peut rendre directement accessibles au public les médicaments de médication officinale** mentionnés à l'art. R.5121-202 du CSP.

Pour quels médicaments ?

Art. R. 5121-202, R. 5121-203, R. 5121-204 du CSP

1° L'AMM n'indique pas qu'ils sont soumis à prescription au titre d'une des catégories prévues à l'article R. 5121-36 ;

2° Les indications thérapeutiques, la durée de traitement, et les informations figurant dans la notice, **permettent leur utilisation, avec le conseil** particulier d'officine prévu à l'article R. 4235-48 CSP, sans qu'une prescription médicale n'ait été établie

3° Le contenu du conditionnement en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise, est **adapté à la posologie et à la durée de traitement** recommandées dans la notice ;

4° L' AMM ou la décision d'enregistrement, ne comporte **pas d'interdiction ou de restriction en matière de publicité** auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique.

L'ANSM gère la liste des médicaments concernés.

Quelles catégories ?

La liste contient :

- des **spécialités pharmaceutiques** (aciclovir, drill, humex, maalox, minoxidil, nicopatch, nicorette, nurofen, sargenor, strepsils...)
- des médicaments **homéopathiques** (arnigel, sédatif PC, tabapass...)
- des médicaments à **base de plantes** (arkogélules, arnica, euphytose...).

L'inscription sur cette liste est une **démarche volontaire du laboratoire, validée par l'ANSM**.

Dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux :

Arrêté du 25 mai 2010 fixant la liste des médicaments contraceptifs oraux visée aux articles L. 4311-1 et L. 5125-23-1 du CSP par Arrêté du 17 juillet 2012 (JO du 19 juillet 2012).

Possibilité est offerte au pharmacien pour **permettre la poursuite d'un traitement contraceptif** pour une durée supplémentaire **non renouvelable de six mois**, les contraceptifs oraux figurant **sur une ordonnance datant de moins d'un an**, dont la durée de validité a expiré, **sauf** s'ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la santé sur proposition de l'ANSM.

La vente par internet :

Suite aux dispositions de l'arrêt de la CJUE connu sous le nom « Arrêt Doc Morris » de décembre 2003, la **vente par internet de certains médicaments est possible en France**. Officialisée par l'Ordonnance du 19 décembre 2012 et le Décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif au **renforcement de la sécurité** de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet (vente à distance). **Entrée en application le 2 janvier 2013.**

Conditions :

- **seuls les médicaments non soumis à prescription obligatoire** peuvent être vendus par internet
- la vente par internet s'effectue à partir d'un **site officinal, labellisé, autorisé par l'ARS**.

Autorisés par l'ARS, les pharmaciens d'officine doivent **informer l'Ordre des pharmaciens de la création du site**.

L'Ordre tient **à jour la liste des sites autorisés**. La liste est également disponible sur le site du Ministère de la santé.

Depuis juillet 2015, les sites de vente en ligne autorisés, doivent afficher sur chaque page du site qui a trait au commerce électronique de médicaments, le logo commun à tous les Etats membres de l'UE.



Dispensation / Délivrance du DM :

Sauf exceptions, les DM ne **relèvent pas du monopole pharmaceutique**.

Ils peuvent être distribués et **vendus ailleurs qu'en pharmacie**.

Certains peuvent ainsi être prescrits par des professionnels de santé autres que les médecins (sages femmes, kinésithérapeutes...).

Art. L5232-3 du CSP

Les **prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM)**, [y compris les dispositifs médicaux destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap], doivent disposer de personnes compétentes.

Quels personnels compétents ?

Quatre catégories de produits / Quatre catégories de personnels garants de l'application des règles professionnelles et de bonne pratique

La catégorie 1 concerne les pharmaciens

- Catégorie 1 : pharmaciens disposant d'un diplôme, titre ou certificat les autorisant à exercer en France.

Arrêté du 19 décembre 2006 modifié décret décembre 2011 :

Pour la catégorie 1 (pharmaciens) :

- les dispositifs médicaux d'oxygénothérapie (pour cette catégorie : monopole pharmaceutique)
- les systèmes actifs pour perfusion
- les matériels pour nutrition entérale
- les appareils de ventilation
- les appareils pour pression positive continue
- les dispositifs médicaux d'aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques

Le pharmacien et le DM :

Tout acte professionnel doit être **accompli avec soin** et attention, selon les **règles de bonnes pratiques** correspondant à l'activité considérée.

L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste à **exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller** attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.

Le pharmacien a **obligation**, comme pour tout produit, **d'informer du prix et du mode d'utilisation**. Il doit aussi vérifier que le patient va **pouvoir utiliser le matériel à domicile**.

Il doit donner au patient le numéro du fournisseur qui se charge, lui-même, en cas de problème, de la réparation et du remplacement si besoin.

Enfin le pharmacien est **responsable de la stérilité du matériel**.

LES PRODUITS DE SANTÉ : UTILISATION / PUBLICITE / PROMOTION

Publicité : Définition code de la consommation :

On entend par publicité **toute forme d'information**, y compris le **démarchage**, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la vente (mais aussi pour les professionnels de santé la prescription, la délivrance ou l'utilisation).

C'est une pratique commerciale

L'article L. 121-1 du Code de la consommation pose un principe général **d'interdiction des pratiques commerciales déloyales** (trompeuses ou agressives).

Une pratique commerciale est **trompeuse** :

- lorsqu'elle crée une **confusion**
- lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou **présentations fausses ou de nature à induire en erreur**
- lorsqu'elle formule des **affirmations matériellement inexactes** en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille, s'il n'achète pas le produit ou le service.

Sanction / Code de la consommation :

Les pratiques commerciales trompeuses sont **punies** des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.

- Sera puni d'un emprisonnement de **deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros** au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers...

L'amende peut être **portée à 50 % des dépenses de la publicité** ou de la pratique constituant le délit.

Publicité Médicaments / Définitions CSP

Art. L.5122-1

« On entend par **publicité** pour les médicaments à usage humain, **toute forme d'information**, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation, qui vise à **promouvoir la prescription**, la **délivrance**, la **vente** ou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une PUI (Pharmacie Usage Interieur). »

Ne sont **pas incluses** dans le champ de cette définition :

- la **correspondance nécessaire** pour répondre à une question précise sur un médicament particulier, émanant d'un professionnel de santé.
- des **informations concrètes** et des documents de référence sur des **sujets sans rapport** avec quelque prospection ou incitation que ce soit (changements d'emballages, mises en garde concernant les effets indésirables, catalogues de vente, listes de prix...).
- des **informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines**, à condition que ces informations ne contiennent aucune référence, même indirecte, à un médicament.

Ex : campagne d'information sur la grippe, le diabète, l'arrêt du tabac...

Produits visés :

Selon l'article L. 5122-3 du CSP :

Seuls les médicaments ayant obtenu l'AMM peuvent faire l'objet de publicité

Mais aussi :

- les produits pour lentilles de contact,
- les pédiculicides et les acaricides
- les générateurs, les trousses et précurseurs
- les produits et objets contraceptifs (autres que les médicaments)

Publicité : Caractéristiques :

La publicité définie à l'article L. 5122-1 du CSP :

- ne doit **pas être trompeuse** (ex : omettre d'indiquer la significativité des résultats d'une étude clinique par l'absence du seuil de significativité (p)).
- **ni porter atteinte à la protection** de la santé publique (ex : omettre de présenter des résultats défavorables en matière de tolérance en occultant les effets indésirables graves).

La publicité doit :

- présenter le médicament ou le produit de **façon objective** (ex : omettre de présenter un groupe de patients présentant des résultats défavorables ou, choisir l'étude particulièrement favorable alors que toutes les autres présentaient des résultats défavorables).
- favoriser son **bon usage en respectant l'AMM**, l'avis de la commission de transparence...
- **respecter les dispositions de l'AMM.**

Le **support** de la publicité peut être :

- une **annonce dans la presse** médicale,
- toute **information promotionnelle diffusée** auprès des professionnels de santé, à l'occasion:
 - de la **présentation** du médicament à des professionnels de santé par des délégués médicaux,
 - des **études**, enquêtes auprès des professionnels,
 - des **réunions**, congrès scientifiques ou émissions télévisées destinées aux professionnels de santé, particulièrement lorsque ceux-ci font l'objet d'un « parrainage » (contribution au financement).

Conditions de Formes :

La publicité pour les médicaments est **soumise à un visa de publicité**.

Dépôt du projet relatif au médicament et à son emballage, à la commission de contrôle de la publicité de l'ANSM.

Si celle-ci accepte, « le visa » est **délivré par le ministère de la santé. Ce visa peut être retiré**.

Le contenu de la publicité varie en fonction du destinataire, consommateur ou professionnel.

Publicité : Professionnels de santé :

La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments est **soumise à une demande d'autorisation préalable de l'ANSM** dénommée « visa de publicité médicale » ou « Visa PM », d'une **validité de 2 ans**.

Publicité : Grand Public :

La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L. 51226 (non PMO, ni remboursable SS, ni interdiction sur AMM), ainsi que les campagnes publicitaires pour certaines vaccinations, sont **soumises à une autorisation préalable de l'ANSM** dénommée « visa de publicité Grand Public » ou Visa GP, d'une **validité de 2 ans**.

Publicité DM, disposition propre :

La réglementation de la promotion des DM est beaucoup **plus récente que celle des médicaments**.

La loi du 29 décembre 2011 [relative au **renforcement de la sécurité sanitaire** du médicament et des produits de santé], a introduit des dispositions concernant la publicité pour les DM, entrées en vigueur au 1er janvier 2013.

La publicité fait l'objet d'un **contrôle a priori ou a posteriori par l'ANSM**

Définition CSP :

Article L5213-1

« On entend par **publicité** pour les DM/DMDIV, toute **forme d'information**, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation, qui vise à **promouvoir la prescription**, la délivrance, la vente ou l'utilisation de ces dispositifs, à l'exception de l'information dispensée dans le cadre de leurs fonctions par les pharmaciens gérant une PUI. »

Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :

- L'étiquetage et la **notice** d'instruction ;
- La **correspondance** nécessaire pour répondre à une question précise sur un DM/DMDIV particulier, d'un professionnel de santé ;
- Les **informations relatives aux mises en garde**, aux précautions d'emploi et aux EI relevés dans le cadre de la matériovigilance, ainsi que les catalogues de ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le DM/DMDIV ;
- Les **informations relatives à la santé humaine** ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence, même indirecte, à un DM/DMDIV.

DM : Publicité pour le professionnels de Santé :

Tous les DM (remboursables/non remboursables) peuvent faire **l'objet de publicité** auprès des PS.

Pour certains DM présentant un **risque important pour la santé** publique et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (implants mammaires, produits de

combler des dépressions cutanées, défibrillateurs cardiaques, stents, etc.), la publicité est **soumise à autorisation préalable de l'ANSM** (contrôle a priori) qu'ils soient remboursables ou non.

Pour les autres, **contrôle a posteriori**.

Publicité pour le grand public :

DM remboursables : la publicité auprès du GP est **interdite, sauf si ces DM sont inscrits sur une liste de DM présentant un faible risque** pour la santé humaine (**classes I et IIa**). Ces publicités font l'objet d'un **contrôle a posteriori et ne nécessitent pas de dépôt à l'ANSM**.

DM non remboursables inscrits sur la liste des DM présentant un risque important pour la santé humaine, (produits de comblement des dépressions cutanées), la publicité auprès du GP est **soumise à autorisation préalable de l'ANSM** (contrôle a priori).

Autres DM non remboursables : les publicités font l'objet d'un **contrôle a posteriori et ne nécessitent pas de dépôt à l'ANSM**.

Publicité : Préservatifs/Contraceptifs :

La publicité des préservatifs et contraceptifs autres que les médicaments, auprès des professionnels de santé, est **soumise à un contrôle a priori**.

La dénomination « visa PR » traditionnellement usitée pour les publicités des préservatifs auprès du public est étendue aux publicités en faveur des contraceptifs autres que médicaments (notamment les DIU).

Publicité : DMDIV

Tous les DMDIV peuvent **faire l'objet de publicité auprès du grand public** (autotests).

La publicité auprès des **professionnels de santé** pour les DMDIV dont la défaillance est susceptible de causer un risque grave pour la santé humaine (réactifs pour certains groupes sanguins, marqueurs, HIV, hépatite etc.), est **soumise à autorisation préalable de l'ANSM**.

Les autres DMDIV font l'objet d'un **contrôle a posteriori et ne nécessitent pas de dépôt à l'ANSM**.

Promotion / Responsabilité :

Les entreprises pharmaceutiques ont **l'obligation de se doter d'un service chargé de la publicité placé sous le contrôle du pharmacien responsable**, qui s'assure du **respect des dispositions du CSP** encadrant la publicité des médicaments, et notamment de la validité scientifique des informations diffusées.

Ainsi, au sein de l'entreprise, c'est le **pharmacien responsable qui est le garant de l'information** concernant le médicament, ainsi que de la promotion.

Publicité / Promotion :

Conformément à l'art. L.162-17-8 du Code de la SS, une **Charte de la visite médicale** a été signée en 2004 entre les entreprises du médicament et le CEPS.

Objectif principal : « **renforcer le rôle de la visite médicale** dans le bon usage des médicaments remboursés aux assurés sociaux, et la qualité de l'information délivrée ».

La **HAS a rédigé un référentiel de certification** sur la base duquel des organismes accrédités par le COFRAC certifient les entreprises ayant une activité de visite médicale.

Charte d'octobre 2014 :

Charte de « l'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments ».

Se substitue à celle de 2004 et **s'applique à l'ensemble des métiers** qui relèvent de « l'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments »

Etablit un certain nombre de dispositions nouvelles relatives à la qualité de l'information, au bon usage du médicament et à l'indépendance des professionnels de santé

Charte et DM :

LFSS 2018 : adoption d'un article visant à créer une « Charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l'information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de services et d'adaptation éventuellement associée ».

Publicité/Promotion :

Art L 4113-6 CSP

Encadrement de la promotion et des pratiques visant à **favoriser l'octroi d'avantages financiers ou en nature** (voyages, cadeaux, invitations...) à des professionnels de santé.

- 1993 modifié 2007 : Loi DMOS (loi portant sur diverses mesures d'ordre social) = **Loi anti-cadeaux**.

Article L1453-1 CSP

- 2011: **Obligations de déclaration des avantages consentis** par les entreprises ou « Sunshine Act à la française » plus grande transparence des acteurs.

Disposition anti-cadeaux :

Réglementation s'appliquant à **tous les produits de santé pris en charge par l'AM**.

« Est **interdit** le fait, pour les étudiants se destinant aux professions [de santé] et pour les membres des professions médicales [...], ainsi que les associations les représentant, de **recevoir des avantages** en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une **façon directe ou indirecte**, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également **interdit** le fait, pour ces entreprises, **de proposer ou de procurer ces avantages**. »

Loi du 4 mars 2002

- a **élargi les sanctions**, jusqu'ici réservées aux professionnels de santé, **aux entreprises** proposant des avantages prohibés.
- a étendu l'interdiction de percevoir des avantages, à certains acteurs de la politique institutionnelle de la santé, tels les experts et les collaborateurs occasionnels scientifiques ou techniques d'agences (comme l'ANSM par ex).

Loi du 29 décembre 2011

- **étend la liste** des personnes concernées par les dispositions anti-cadeaux (étudiants des professions de santé).
- nouvelles mesures visant à **renforcer la transparence** entre les acteurs :
 - les **entreprises doivent publier l'existence des conventions** qu'elles concluent avec les professionnels de santé, les étudiants, les associations etc., et sont tenues de **rendre publics les avantages qu'elles procurent**.

Prévention et transparence des conflits d'intérêt :

Décret du 21 mai 2013 (relatif à la **transparence des avantages accordés** par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme) :

- **obligation d'une déclaration publique d'intérêts** qui mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que les professionnels ont ou ont eus avec des entreprises du secteur de la santé **pendant les cinq années précédant leur prise de fonctions**.
- liens d'intérêt consultables sur : www.transparence.sante.gouv.fr

Les échantillons :

Art. L. 5122-10 du CSP

- des échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être **remis aux PS que sur leur demande**. Ils doivent être **identiques aux spécialités** pharmaceutiques concernées et porter la **mention "échantillon gratuit"**.
- Art. R. 5122-17 du CSP (décret du 9 mai 2012) :
 - seuls les **nouveaux médicaments** peuvent faire l'objet d'une remise d'échantillons, **pendant les 2 ans suivant la 1ère commercialisation** en France,
 - limité à quatre par an et par destinataire,
 - de la plus petite présentation et du plus faible dosage

LES PRODUITS DE SANTE : UTILISATION - SURVEILLANCE

Pharmacovigilance :

« Ensemble des procédures, méthodes ou techniques visant à surveiller, évaluer, prévenir et **gérer le risque d'effet indésirable** résultant de l'utilisation des médicaments, que ce risque soit **potentiel ou avéré**. Pour les médicaments **mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit** »

La pharmacovigilance repose avant tout sur le **signalement des effets indésirables susceptibles d'être dus aux médicaments** ou produits mentionnés à l'article L.5121-1 du CSP.

Obligation de déclaration des professionnels de santé dès qu'ils **soupçonnent** un lien, **même s'il n'est pas certain**.

Obligation de déclaration :

Art R 5121-151 modifié par décret du 8 novembre 2012

Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou le pharmacien **déclarent immédiatement** tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou à un produit dont ils ont connaissance.

Que déclarer ? Toute suspicion :

- d'effet indésirable médicamenteux,
- d'erreur médicamenteuse,
- de mésusage, d'abus, de surdosage,
- d'exposition professionnelle à un médicament
- que l'effet soit **connu ou non**, qu'il soit **grave ou non**.

Définitions :

Effet indésirable :

- réaction **nocive**, **non voulue** à un médicament, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour le rétablissement, la rectification ou la modification d'une fonction physiologique.

Effet indésirable grave :

- entraînant le **décès ou mettant en jeu le pronostic vital** ou entraînant une **invalidité** ou une **incapacité significative** ou entraînant/prolongeant une hospitalisation ou entraînant une anomalie ou malformation congénitale.

Elargissement de la définition de l'EI :

- couvre dorénavant les **réactions nocives survenues dans toutes les situations d'utilisation** (mésusage, abus, surdosage, erreurs médicamenteuses, absence d'effet thérapeutique, rumeurs, mauvaise observance, exposition professionnelle, rupture de la chaîne du froid...).

Effet indésirable inattendu :

- dont la nature, la gravité, l'effet, l'évolution, ne **concordent pas avec le RCP**.

Mésusage :

- Utilisation **intentionnelle** et **inappropriée** d'un médicament ou d'un produit, **non conforme à l'AMM** ainsi qu'aux recommandations de **bonnes pratiques** (non conforme au RCP).

Imputabilité :

- **Analyse** au cas par cas du **lien de causalité** entre la prise d'un médicament et la **survenue d'un événement indésirable**.

France - La Pharmacovigilance :

Elle comporte (Art. R 5121-151 CSP) :

- Le **signalement des effets indésirables** et le recueil des informations les concernant ;
- **L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation** de ces informations dans un but de prévention ; ces informations sont analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente, la délivrance et les pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux patients des médicaments et produits ;
- La **réalisation de toutes études et travaux** concernant la sécurité d'emploi des médicaments.

Les acteurs :

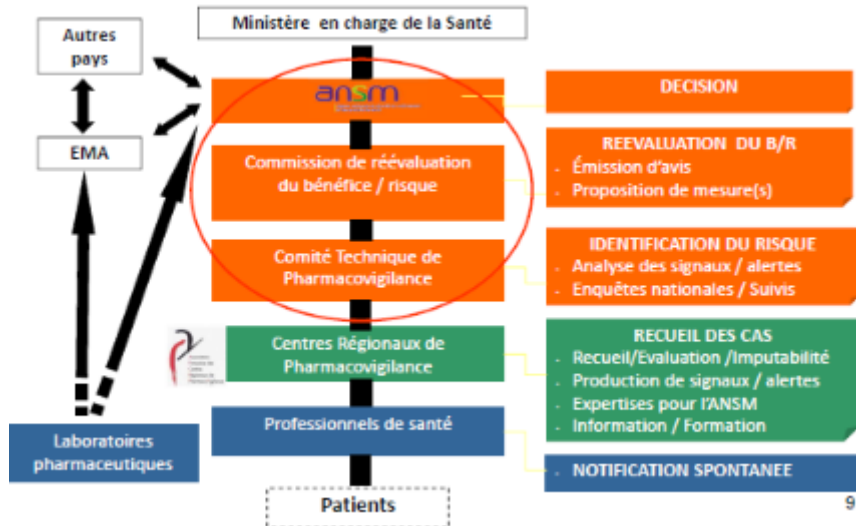
Le système national comprend :

- **L'ANSM**
- Le **Comité technique** (assure l'interface avec les réseaux de terrain)
- Les **Centres régionaux**
- Les membres des **professions de santé**, les **entreprises** ou organismes exploitant un médicament, ainsi que les PUI
- Sans oublier les **patients** et les associations de patients

Le système français :

Se caractérise par :

- un réseau de **31 CRPV**
- **l'emploi**, par tous les spécialistes concernés, d'une **méthode d'imputabilité commune** imposant un contrôle de qualité des informations recueillies, de façon à pouvoir établir un **score évaluant la relation de causalité** entre un événement indésirable et un ou des traitements
- la **centralisation et l'évaluation** de l'ensemble de ces données par **l'ANSM**



Commission de suivi du rapport bénéfices/risques :

Consultée si sont envisagés :

- une **réévaluation** du rapport B/R
- des **modifications substantielles des AMM** notamment sur les rubriques de sécurité figurant dans les RCP
- des **modifications des conditions de prescription** et de délivrance produits de santé
- l'élaboration ou la mise à jour de certains **plans de gestion des risques** de médicaments déjà autorisés (sauf médicaments psychoactifs)
- la **surveillance** et le contrôle de certains dispositifs médicaux
- certains **arrêts de commercialisation**

Exigences communautaires :

Système de gestion de risque pour chaque médicament dont :

- **plans de gestion des risques (PGR)** et
- mesures de **minimisation des risques (MMR)**

Système de Pharmacovigilance

Personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance

Tenue d'un dossier permanent du système de pharmacovigilance

Définition d'un PGR :

Plan de PV renforcé qui permet dans une **démarche proactive**, de détecter et quantifier **tout signal d'effet indésirable**, mieux connaître le profil de sécurité d'emploi et minimiser les risques liés à l'utilisation d'un médicament :

- **informations manquantes lors de l' AMM** notamment populations à risque

- **surveillance du bon usage dans les conditions réelles** d'utilisation, et identification des pratiques s'éloignant du bon usage
- **risque potentiel et risque connu**

Plan de Gestion de Risques :

Depuis 2005 (et renforcement en 2012) pour :

- **Toute nouvelle substance**, tout **biosimilaire**, toute **biothérapie**
- **Tout générique** si problème identifié avec le princeps
- **Extension d'AMM** (dosage, voie, procédé de fabrication, indication, extension pédiatrie)
- **A la demande des autorités compétentes** en cas de signal de PV identifié **à n'importe quelle étape de la vie du médicament**

Pharmacovigilance dans l'UE :

Textes communautaires

- **Règlement** (UE) N°1235/2010 du parlement européen et du conseil du 15 décembre 2010
- **Directive** 2010/84/UE du Parlement européen et du conseil du 15 décembre 2010
- Les **bonnes pratiques de pharmacovigilance** (de 2005 avec actualisation en 2011 et en février 2018)

Les acteurs :

L' EMA ⇔ Système de PV au **niveau communautaire**.

Reproduit l'organisation française : recueil et validation décentralisés au niveau de chaque état membre, évaluation et avis et/ou décision centralisés au niveau européen.

Comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) : évalue les risques ainsi que les mesures de suivi et de gestion de ces risques.

Base de données : **EudraVigilance database**

Médicaments sous surveillance renforcée :

Sur décision du PRAC

Médicaments concernés :

- **nouvelle substance active**
- **biologique** (vaccin, médicament dérivé du sang)
- bénéficie d'une **autorisation conditionnelle** (demande de données complémentaires)
- études de sécurité **post autorisation**

Symbole spécifique et mention (RCP, notice)



Retrait de la liste après 5 ans

Depuis mars 2017 , les **professionnels de santé ou les usagers peuvent signaler** en quelques clics aux autorités sanitaires tout événement indésirable sur le site signalement-sante.gouv.fr dont les effets indésirables, incidents ou risques d'incidents liés aux produits de santé.

Les décisions :

Retrait de lot

Modification du RCP

Modification du conditionnement

Restriction de prescription, d'utilisation

Suspension ou retrait de l'AMM

La matériovigilance :

Décret du 15 janvier 1996 modifié par le décret en Conseil d'Etat du 04 mars 1999.

La matériovigilance concerne la **surveillance/prévention des incidents ou des risques d'incidents** résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux qui sont définis à l'article L.5211-1.

S'exerce sur les DM après leur mise sur le marché.

A pour objectif **d'éviter que ne se (re)produisent des incidents** et risques d'incidents graves mettant en cause des DM, en prenant les mesures préventives et/ou correctives appropriées.

Elle comporte, notamment, le **signalement, l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation** des informations signalées, dans un but de prévention.

Acteurs de la matériovigilance :

Echelon national

- l'ANSM

Echelon local

- correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé,
- fabricants,
- quiconque ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident : les utilisateurs et les tiers.

Domaine d'application :

S'applique à tous DM tels que définis à l'article L.5211-1 du CSP notamment :

- les consommables à usage unique ou réutilisables
- les implants passifs ou actifs
- les équipements

L'évaluation doit essayer de répondre aux questions suivantes :

- le DM peut-il être en cause ?
- le risque d'incident ou l'incident est-il grave ?
- le risque d'incident ou l'incident est-il reproductible ?

Obligations réglementaire en matériovigilance :

Art L.5212-2 :

Signalement obligatoire et sans délai

- d'un **incident ou d'un risque** d'incident mettant en cause un dispositif **ayant entraîné ou susceptible** d'entraîner la **mort ou la dégradation grave de l'état** de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'autorité administrative.
- **Tout rappel de dispositif du marché**, motivé par une raison technique ou médicale.

Article R.5212-15 :

Les autres événements indésirables **peuvent être signalés selon une périodicité trimestrielle et de manière facultative.**

Le règlement (UE) 2017/745 (obligatoire à compter de mai 2020), modifie les règles de matériovigilance.

Matériovigilance au **cas par cas** :

- Les **fabricants devront notifier** via Eudamed à l'ANSM les éléments suivants :
 - tout **incident grave** ;

- toute **mesure corrective de sécurité** prise à l'égard d'un dispositif présent sur le marché de l'UE ;
- la notification sera faite dès l'établissement de l'imputabilité et en tout état de cause dans des **délais de 2 à 15 j**

Surveillance après commercialisation :

Pour chaque dispositif, **les fabricants** conçoivent, établissent, documentent, appliquent, maintiennent et mettent à jour un **système de surveillance après commercialisation** en fonction de la classe de risque et du type de dispositif.

Le **rapport périodique** actualisé de surveillance (**classes IIa, IIb, III**) et le **rapport** sur la surveillance (**classe I**) font la **synthèse des résultats et des conclusions de l'analyse des données de surveillance** exposant la justification de toute mesure préventive ou corrective prise et les décrivant.

Responsabilité élargies des producteurs (REP) - Médicament et DM :

Démarches et dispositifs qui restaurent la **responsabilité du producteur de produits manufacturés** pour ce qui concerne la **gestion des déchets finaux ou intermédiaires** générés par les produits qu'il a fabriqués ou mis sur le marché.

Pour **réduire la production de déchets**.

Cadre réglementaire :

La directive 2004/27/CE prévoit que **tout EM de l'UE doit veiller** à « la mise en place de **systèmes de collecte appropriés** pour les médicaments inutilisés ou périmés ».

En France, il a été décidé de rendre **obligatoire la mise en place d'une filière REP** pour la gestion des MNU.

L'art. 32 de la loi n° 2007-248 indique que **toute pharmacie française a l'obligation de collecter gratuitement les médicaments** à usage humain non utilisés, rapportés par les particuliers (sans les emballages en carton).

Organisation de la filière :

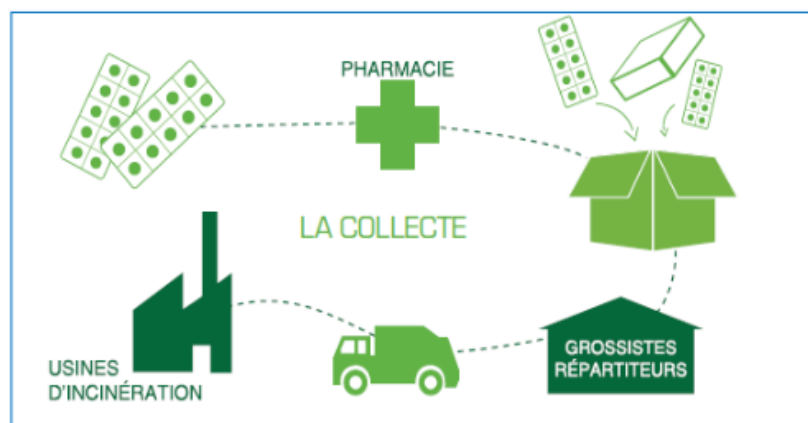
En France, **l'association Cyclamed** est à l'origine du dispositif de collecte spécifique des MNU depuis 1993.

Regroupe l'ensemble des acteurs de la profession pharmaceutique

- pharmaciens,
- grossistes répartiteurs
- lab. pharmaceutiques (192 en 2014).

Élimination des déchets par incinération.

Modalité de collecte :



Elimination - Médicaments :

Protection des personnes

Cas de stupéfiants :

Les pharmaciens sont les **garants** de la mise en œuvre de la réglementation en matière de stupéfiants.

- Procédure de **dénaturation** mise en place par **l'Ordre des Pharmaciens**
- **Conservation** des produits concernés dans une armoire ou un local fermé à clef
- À l'officine, le pharmacien titulaire doit **solliciter le Conseil régional de l'Ordre** afin qu'il désigne un **pharmacien « témoin »**
- Le pharmacien "demandeur" **choisit le procédé de dénaturation le plus adapté** pour rendre les produits concernés définitivement inutilisables à quelques fins que ce soit
- **Procès verbal conservé 10 ans**

Cas de certains patches : destruction par découpage avant incinération avec les ordures ménagères.

Elimination - DM :

L'élimination des DM après utilisation, s'intègre dans la **démarche générale de l'élimination des déchets de soins**.

La réglementation repose à la fois sur le **code de l'environnement et sur la notion de déchet ultime** qui y est définie, avec le respect de **4 principes** :

- **prévention** ou **réduction** des déchets,
- **organisation** de leur transport,
- valorisation, **recyclage**
- **information** du **public** sur les effets pour l'environnement et la santé publique

Relève :

Soit des **dispositions spécifiques aux déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)**, définis aux Art R1335-1 à R 1335-14 du CSP, en particulier pour **tous les DM à risque d'accident d'exposition au sang** et tous ceux ayant collectés des liquides biologiques potentiellement pathogènes .

Soit de **dispositions spécifiques inhérentes aux produits « toxiques »** (mercure, piles, émission de radiations diverses, etc.).

Soit des **démarches de valorisation pour les DM d'équipements en particulier**.